

<u>Nom du test ou de la manœuvre</u>	<u>Description</u>	<u>Photos ou illustration</u>
a. Présentation clinique fréquente indiquant la réalisation du test b. Signification de la positivité c. Commentaires	a. Position et action du patient b. Action de l'examineur c. Pièges à éviter	
<u>Evaluation de la marche</u> a. Tous le patient b. Marche ataxique (ex. myelopathie) : instable, élargissement polygone de sustentation Steppage (ex. lésion L5)	a. Faire marcher le patient dans le box de consultation, aussi sur les talons et les pointes des pieds b. Observation de la marche (alignement du bassin, flexion et extension des pieds, petits pas, polygone de sustentation)	
<u>Evaluation/Inspection de la posture</u> a. Suspicion d'une difformité de la colonne Norme: Vue de face : alignement vertical Vue de profil : lordose cervicale et lombaire, cyphose thoracique Scoliose : typiquement gibbosité thoracique et bourrelet lombaire, asymétrie triangle de taille difformité sagittale avec hypolordose lombaire (fréquent, souvent dégénératif) et/ou hypercyphose (ex maladie de Scheuermann, fractures)	a. patient déshabillé jusqu'aux sous-vêtements b. Inspection de la posture profil et face (de derrière), demander patient de pencher en avant pour identifier une gibbosité comme signe de scoliose ; évaluation si bassin est horizontal si inégalités de longueur des membres inférieurs (si nécessaire égalisation de la longueur des jambes par talonnette ou examination en position assise)	
<u>Recherche d'un déficit d'une racine lombaire</u> a. Douleur irradiant (radiculaire) vers le membre inférieur (habituellement unilatérale), souvent typiquement lors d'une compression d'une racine nerveuse (ex. hernie discale)	a. Patient en position couchée (ou assise) b. Tester la sensibilité dans les dermatomes, demander de pousser contre gravité/résistance pour tester	

b. Déficit sensitif dans le territoire d'innervation d'une racine nerveuse (dermatome) et/ou déficit moteur du muscle spécifique de la racine (myotome) c. Myotome lombaire : L1/L2 Flexion hanche (iliopsoas), L3/L4 Extension genou (quadriceps), L4/L5 Extension pied (tibialis ant.), L5 Extension hallux, L5 Abduction hanche (m. moyen fessier, Trendelenburg), S1 Flexion plantaire	les muscles de toutes les myotomes et grader la force M0-M5. Comparer gauche et droite. c.	
<u>Recherche d'un déficit d'une racine cervicale</u> a. Douleur irradiant (radiculaire) vers le membre supérieur (habituellement unilatérale), souvent typiquement lors d'une compression d'une racine nerveuse (ex. sténose foraminale, hernie discale) b. Déficit sensitif dans le territoire d'innervation d'une racine nerveuse (dermatome) et/ou déficit moteur du muscle spécifique de la racine (myotome) c. Myotome cervical : C5 Abduction épaule, C6 Flexion coude, Extension poignet, C7 Extension coude, Flexion poignet, C8 Flexion doigts, Abduction doigts	a. Patient en position assise b. Tester la sensibilité dans les dermatomes, demander de pousser contre gravité/résistance pour tester les muscles de toutes les myotomes et grader la force M0-M5. Comparer gauche et droite. c.	
<u>Recherche des réflexes ostéo-tendineux physiologiques</u> a. Suspicion d'une lésion nerveuse (motoneurone supérieur ou inférieur) b. Lésion motoneurone supérieur (Atteinte cérébrale ou moelle épinière) : hyperréflexie Lésion motoneurone inférieur (Atteinte racine, nerf périphérique) : hyporéflexie	a. Plusieurs options, en générale patient assis b. R. biceps : Index de l'examineur sur l'insertion du tendon, coup de marteau sur index R triceps : coup de marteau sur insertion du tendon R rotulien : coup de marteau sur tendon rotulien en infra-patellaire	

c. Réflexes ostéo-tendineux C6 Biceps , C7 Triceps L3, L4 Rotulien, S1 Achilléen	R achilléen : coup de marteau sur tendon d'Achille	
<u>Manœuvre de Lasèque</u> a. Suspicion d'une compression L5 ou S1 b. Reproduit la douleur et la paresthésie dans le membre inférieur lors de la flexion passive de la hanche c. Le résultat physique le plus important et le plus prédictif pour identifier les bons candidats à la chirurgie.	a. Patient en décubitus dorsal b. Soulever le membre inférieur passivement jusqu'à apparition de la douleur c. Apparition des douleurs lombaires n'est pas considérée comme positif	
<u>Manœuvre de Retro-Lasèque</u> a. Suspicion d'une compression L3 ou L4 b. Reproduit la douleur et la paresthésie dans le membre inférieur lors de l'hyperextension passive de la hanche	a. Patient en décubitus latéral b. Réaliser une hyperextension passive de la hanche	
<u>Test de Spurling</u> a. Suspicion d'une compression radiculaire cervicale b. Reproduit des douleurs radiculaires c. Très spécifique, mais faible sensibilité	a. Patient assis b. Extension, rotation vers le côté affecté, flexion latérale et compression axiale simultanées.	
<u>Signe de Babinski</u> a. Suspicion d'une lésion du motoneurone supérieur/tractus corticospinal (ex. compression moelle épinière) b. Extension hallux, les autres orteils écartés c. Normal/négatif : flexion de toutes les orteils	a. Patient couché b. Stimuler par appui (manche du marteau réflexe par exemple) le bord latéral du pied et se diriger sous le coussinet plantaire du gros orteil	
<u>Signe de Hofmann</u>	a. Patient couché ou assis	

a. Suspicion d'une lésion du motoneurone supérieur/tractus corticospinal (ex. compression moelle épinière cervical) b. Flexion/adduction du pouce et flexion index c. Une réponse faible peut être normale	b. la main détendue est tenue avec le poignet en dorsiflexion et les doigts partiellement fléchis. D'une main, l'examineur tient le majeur partiellement étendu entre l'index et le pouce. D'un coup sec et forcé de l'autre pouce, l'examineur fait claquer l'ongle du majeur du patient, forçant le doigt distal à une flexion brusque suivie d'un relâchement soudain.	
<u>Test de Romberg</u> a. Suspicion d'une lésion cordonale postérieure (ex. compression moelle épinière) b. position instable avec les yeux fermés	a. se tient debout, les mains tendues vers l'avant, ferme les yeux b. s'assurer que le patient ne tombe pas	
<u>Évaluation de la sensibilité</u> a. Suspicion d'une lésion nerveuse b. Déficit d'un des cinq modalités de sensation : vibration, proprioception, touché fin, touché-piqué, température c. Distribution et déficit indique l'origine du problème : nerf périphérique, racine (dermatome), neuropathie périphérique (distale, en « chaussette »), moelle épinière (complète ou incomplète)	a. Patient couché ou assis b. Test de sensibilité sur les différents territoires d'innervation (dermatomes, nerf périphérique) Vibration : diapason Proprioception : tenir la phalange distale du gros orteil et le fléchir ou l'étendre passivement en demandant au patient de fermer les yeux. Demander ensuite au patient si l'orteil et déplacer dans sa direction (extension de l'orteil) ou dans la direction opposée (flexion de l'orteil) Touché fin : demander au patient de discriminer 2 points de distances se réduisant	

	Touché-piqué : alterner stimulus « piqué » = extrémité pointue et « touché » = extrémité plus large Température : appliquer qqch de chaud puis de froid et demander au patient s'il ressent une différence de température	
--	---	--